

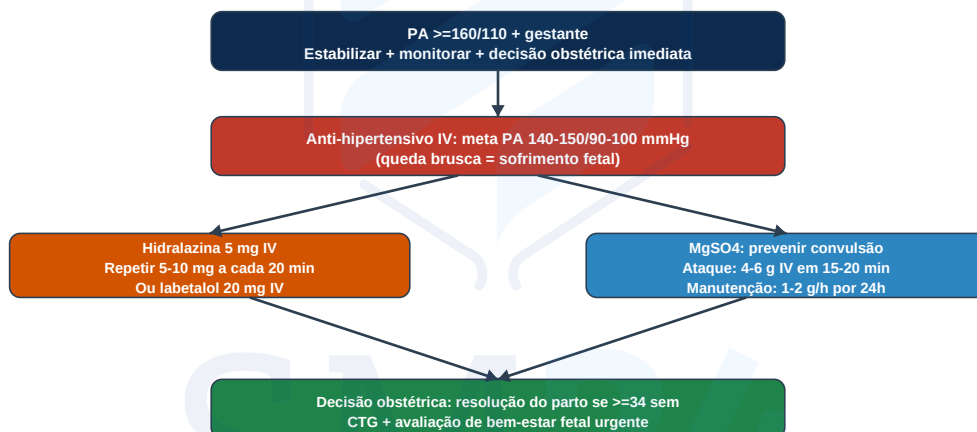
PRÉ-ECLÂMPسيا — CONTROLAR PA + MgSO₄

CLASSIFICAÇÃO — HIPERTENSÃO NA GESTAÇÃO

Diagnóstico	Definição	Risco
Hipertensão gestacional	PA $\geq$ 140/90 após 20 semanas SEM proteinúria/critérios graves	Moderado — 25% evolui para PE
Pré-eclâmpsia (PE)	PA $\geq$ 140/90 após 20 sem + proteinúria $\geq$ 300 mg/24h OU critérios de gravidade	Alto — risco de eclâmpsia/HELLP
PE com critérios de gravidade	PAS $\geq$ 160 OU PAD $\geq$ 110 OU cefaleia/escotomas/epigastria/plaquetas $<$ 100k/creatinina $>$ 1,1	Muito alto — internar
Eclâmpsia	PE + crise convulsiva (sem outra causa)	Altíssimo — MgSO ₄ + resolver parto
Síndrome HELLP	Hemólise + enzimas hepáticas elevadas + plaquetas baixas ($<$ 100k)	Altíssimo — pode ser sem HAS
Hipertensão crônica	HAS antes de 20 semanas ou pré-existente	Moderado — vigiar PE superimposta

MANEJO DA CRISE HIPERTENSIVA OBSTÉTRICA

CRISE — CONTROLAR PA + PREVENIR CONVULSÃO



ANTI-HIPERTENSIVOS NA CRISE OBSTÉTRICA

Droga	Dose IV	Observações
Hidralazina	5 mg IV lento; repetir 5-10 mg a cada 20 min (máx 40 mg)	1ª escolha no Brasil; venodilatador; taquicardia reflexa possível
Labetalol	20 mg IV; dobrar dose a cada 10 min (máx 300 mg) OU infusão 1-2 mg/min	Alfa+beta bloqueador; não usar em asma; pode ser preferido em taquicardia
Nifedipino VO	10-20 mg VO; repetir a cada 30 min (máx 60 mg)	Alternativa oral; NÃO usar sublingual (queda brusca)
Nitroprussiato IV	0,5-10 mcg/kg/min	Somente se refratária; risco de intoxicação por cianeto fetal — uso brevíssimo
EVITAR	IECA, ARA II (captopril, enalapril, losartan)	Contraindicados — nefrotóxicos para o feto

SÍNDROME HELLP — RECONHECER E AGIR

HELLP = URGÊNCIA OBSTÉTRICA

- H — Hemólise: esquizócitos no esfregaço, LDH >600, bilirrubina indireta elevada
- EL — Elevated Liver enzymes: TGO/TGP >70 UI/L, dor epigástrica em barra
- LP — Low Platelets: PLQ <100.000/mcL (grave: <50.000)
- HELLP pode ocorrer SEM hipertensão em 10-20% — não excluir pelo nível de PA
- Tratamento definitivo: RESOLUÇÃO DO PARTO — não existe tratamento conservador seguro após 34 semanas
- Corticoide: dexametasona 10 mg IV 12/12h se <34 semanas para maturidade fetal

ECLÂMPSIA — MANEJO DA CRISE

Crise Convulsiva

- Posição lateral + proteção da via aérea
- O2 100% por máscara
- MgSO4 4 g IV em 5-10 min (se ainda não em uso)
- Se convulsão persistir >5 min: diazepam 10 mg IV
- Não usar fenitoína (ineficaz na eclâmpsia)
- Após estabilização: resolução do parto

Monitoração do MgSO4

- Reflexo patelar presente (perde com Mg ~4-5 mEq/L)
- FR >12/min (paralisia respiratória com Mg ~5-6 mEq/L)
- Diurese >25 mL/h (Mg excretado pelo rim)
- Antídoto: gluconato de cálcio 1 g IV
- Dosar Mg se creatinina elevada (risco de acúmulo)
- Manter por 24h pós-parto

PROFILAXIA E DIAGNÓSTICO PRECOCE

RASTREIO E PREVENÇÃO DA PE

- ☐ AAS 100-150 mg/dia a partir de 12-16 semanas em gestante de alto risco (DM, HAS crônica, PE prévia, gemelar)
- ☐ Doppler de artérias uterinas no 1o trimestre: IG pré-PE
- ☐ Proteinúria: dipstick >=2+ em 2 amostras OU proteinúria de 24h >=300 mg
- ☐ PAPP-A baixo + PIGF baixo: marcadores de placentação anômala
- ☐ Internar se: critérios de gravidade, HELLP, eclâmpsia, sofrimento fetal
- ☐ Corticoide antenatal: betametasona 12 mg IM 2 doses em 24h se <34 semanas e parto iminente

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Gestante de 32 semanas com PA 170/110 mmHg, cefaleia intensa e escotomas visuais. Qual é o diagnóstico e a primeira medida terapêutica?

- A) Hipertensão gestacional — metildopa 250 mg VO
- B) Pré-eclâmpsia com critérios de gravidade — hidralazina 5 mg IV + MgSO₄ 4 g IV
- C) Eclâmpsia — diazepam IV imediato
- D) Hipertensão crônica reagudizada — nifedipino sublingual
- E) HELLP — transfusão de plaquetas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Gestante com HELLP em 35 semanas. Qual é a conduta definitiva?

- A) Corticoide + repouso + acompanhar ambulatorialmente
- B) Resolução do parto — tratamento definitivo da síndrome HELLP
- C) Plasma fresco congelado + plaquetas + aguardar 38 semanas
- D) Heparina para prevenir trombose placentária
- E) Betametasona e aguardar maturidade fetal até 37 semanas

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que o nifedipino sublingual é CONTRAINDICADO na crise hipertensiva obstétrica?

- A) Porque causa bradicardia fetal
- B) Porque reduz a PA de forma imprevisível e brusca, com risco de sofrimento fetal por hipoperfusão placentária
- C) Porque é teratogênico
- D) Porque bloqueia os canais de Ca²⁺ cardíacos do feto
- E) Porque interage com MgSO₄ causando bloqueio AV

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Gestante de 30 semanas, 1ª consulta de pré-natal, com PA 150/100. Sem proteinúria. Qual diagnóstico e qual medicamento é contraindicado para tratamento da HAS na gestação?

- A) Pré-eclâmpsia — contraindicar betabloqueadores
- B) Hipertensão gestacional — contraindicar diuréticos
- C) Hipertensão crônica ou gestacional — contraindicar IECA/ARA-II (captopril, enalapril, losartan)
- D) Hipertensão gestacional — contraindicar hidralazina
- E) Crise hipertensiva — contraindicar metildopa

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Gestante de 31 semanas em eclâmpsia ativa (convulsão). Qual é a conduta imediata?

- A) Fenitoína 20 mg/kg IV para cessar a convulsão
- B) Diazepam IV + manobra de Sellick
- C) Posição lateral + O₂ + MgSO₄ 4 g IV em 5-10 min
- D) Cesárea de urgência antes de controlar convulsão
- E) TC de crânio para excluir AVC antes de tratar

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

PE com critérios de gravidade: PA $\geq 160/110$ + sintomas neurológicos (cefaleia, escotomas). Conduta: controlar PA (hidralazina 5 mg IV — meta 140-150/90-100) + MgSO₄ (prevenir convulsão) + internação + decisão obstétrica (parto se ≥ 34 semanas).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

HELLP: o único tratamento definitivo é a resolução do parto — interrupção da gestação resolve o processo fisiopatológico (isquemia placentária). Após 34 semanas ou com deterioração materna: parto imediato. Antes de 34 sem: corticoide para maturidade fetal + parto em 24-48h.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Nifedipino sublingual: absorção imprevisível e rápida → queda brusca e excessiva da PA → isquemia placentária → sofrimento fetal. Usar nifedipino VO (liberação gradual) ou hidralazina/labetalol IV. Meta é reduzir PA gradualmente (não normalizar rapidamente).

QUESTÃO 4 → Resposta: C

IECA (captopril, enalapril) e ARA-II (losartan) são contraindicados na gestação — nefrotóxicos para o feto, causam oligohidrânio, hipoplasia renal, malformações. Usar: metildopa, nifedipino VO, labetalol. Diuréticos: não recomendados de rotina (reduzem volemia).

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Eclâmpsia em crise convulsiva: posição lateral (previne aspiração), O₂ 100%, MgSO₄ 4 g IV em 5-10 min (anticonvulsivante de escolha). Fenitoína é ineficaz na eclâmpsia. TC só se refratária ao Mg ou déficit focal persistente. Cesárea após estabilização da paciente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico